输血:总血量5L 1000ml（20%）
休克:总血量4L 800ml

三、分度

1.休克早期/代偿期/轻度

①失血量＜20%（＜800ml）

②收缩压正常或稍↑、舒张压↑、脉压↓休克了,降个级

（微动脉收缩→外周阻力↑→舒张压显著↑、收缩压轻度↑）代偿血压

2.休克期/失代偿期（看2）《各论》休克默认"休克期",默认收缩压<90

	中度	重度
失血量	20-40%	＞40%（＞1600ml）
脉搏	100-200 次/分	速（＞200）而弱（摸不清）
收缩压	90-70、脉压↓	＜70
神志	尚清楚、表情淡漠	意识模糊、昏迷

复习《生理学》：动脉血压的形成条件和影响因素

形成条件	影响因素					
	影响因素	变化举例	收缩压	舒张压	脉压	主要影响
足够血液充盈	平均充盈压	循环血量↓或循环系统容积↑→平均充盈压↓→搏出量↓	↓↓	↓	↓	收缩压
心脏射血	搏出量	↑	↑↑	↑	↑	收缩压
	心率	↑	↑	↑↑	↓	舒张压
外周阻力	外周阻力	↑	↑	↑↑	↓	舒张压
大动脉弹性储器	大动脉弹性储器	↓（老年人大动脉硬化）	↑	↓	↑↑	脉压

四、监测

1.休克指数=脉率/收缩压：0.5 无休克、＞1-1.5 休克、＞2 严重休克　脉率跳得越快,收缩压越低,休克指数就越大

2.尿量　血流重新分配最先分配肾脏,肾脏恢复说明心脑已恢复

①尿量达 30ml/h：微循环已改善、液体已补足

②尿量＜25ml/h 且**尿比重增加**：血容量不足致肾血管收缩（肾前性肾衰）

③血压正常但尿量仍少且**尿比重低**：肾性肾衰

肾前性	肾性-ATN
尿比重高	尿比重低

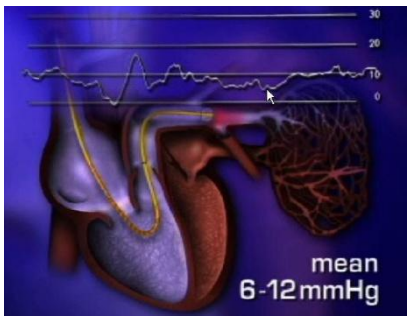
肾脏浓缩功能↓,对水的吸收↓,将尿稀释

敏感

3.胃肠道 pH：发现隐匿性休克

BE <-2.3→代酸、>+2.3→代碱

4.乳酸、碱剩余：评估缺氧、酸中毒、无氧代谢程度、预后



5.肺小动脉/毛细血管楔压 PAWP/PCWP：反映肺静脉、左心房、左心室功能状态

右心漂浮导管　左心衰→血液淤滞在肺→肺小A末端压力↑

6.**中心静脉压 CVP（5-10cmH_2O）**

①代表右心房、胸腔大静脉压力